Основы сестринского дела · лекция 8 · 28 сентября

Микрофлора рук, обработка рук, аварийные ситуации

Резидентная и транзиторная флора, патогенные, условно-патогенные и оппортунисты, проблемные зоны кожи рук, уровни обработки рук, хирургическая обработка, перчатки, алгоритм при уколе/порезе (профилактика ВИЧ)

1. Микрофлора рук

> **СУТЬ**
> На руках живёт «своя» постоянная флора и временная, «чужая», которую мы подхватываем на работе. Именно временная опасна для пациентов.

Резидентная (нормальная)	Транзиторная
Микроорганизмы, которые **постоянно живут и размножаются** на коже	Не колонизирующая флора, приобретённая персоналом **в процессе работы** при контакте с инфицированными объектами окружающей среды
	Сохраняется на руках **не более 24 часов**; удаляется обычным мытьём рук и обработкой антисептиком

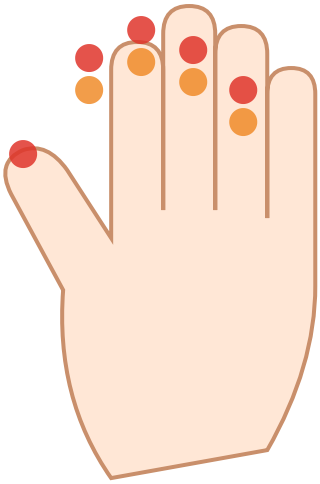
Транзиторная флора — в основном микроорганизмы внешней среды, опасные в эпидемиологическом отношении: **сальмонеллы, ротавирусы, шигеллы, вирус гепатита А** и т. д.

2. Патогенность микробов

1. **Патогенная** микрофлора — вызывает клинически выраженные заболевания у **здоровых** людей.
2. **Условно-патогенная** — вызывает заболевание только при наличии специфического **предрасполагающего фактора**.
3. **Оппортунисты** («приспособленцы») — вызывают генерализованные заболевания только у больных с **отсутствием иммунитета**.

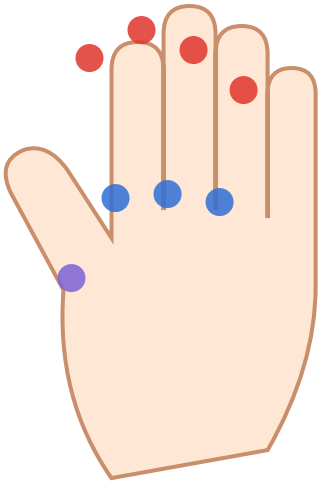
- Условно-патогенные грамположительные: **стафилококки** (в т. ч. эпидермальный).
- Грамотрицательные: **кишечная палочка, клебсиеллы** и т. д.
- Грибы: **кандиды** (кандидоз).

3. Проблемные зоны кожи рук



- подногтевое пространство
- околоногтевые валики
- подушечки пальцев

Самые загрязнённые



- подногтевое пространство
- межпальцевые промежутки
- выемка большого пальца

Хуже всего промываются

Где больше всего микробов и что хуже всего промывается

Наиболее загрязнённые участки	Наиболее сложно промываемые участки
1) подногтевое пространство	1) подногтевое пространство
2) околоногтевые валики	2) межпальцевые промежутки
3) подушечки пальцев	3) выемка большого пальца

ВАЖНО

Подногтевое пространство — в обоих списках: самое грязное и хуже всего отмывается. Отсюда правило коротких ногтей без лака.

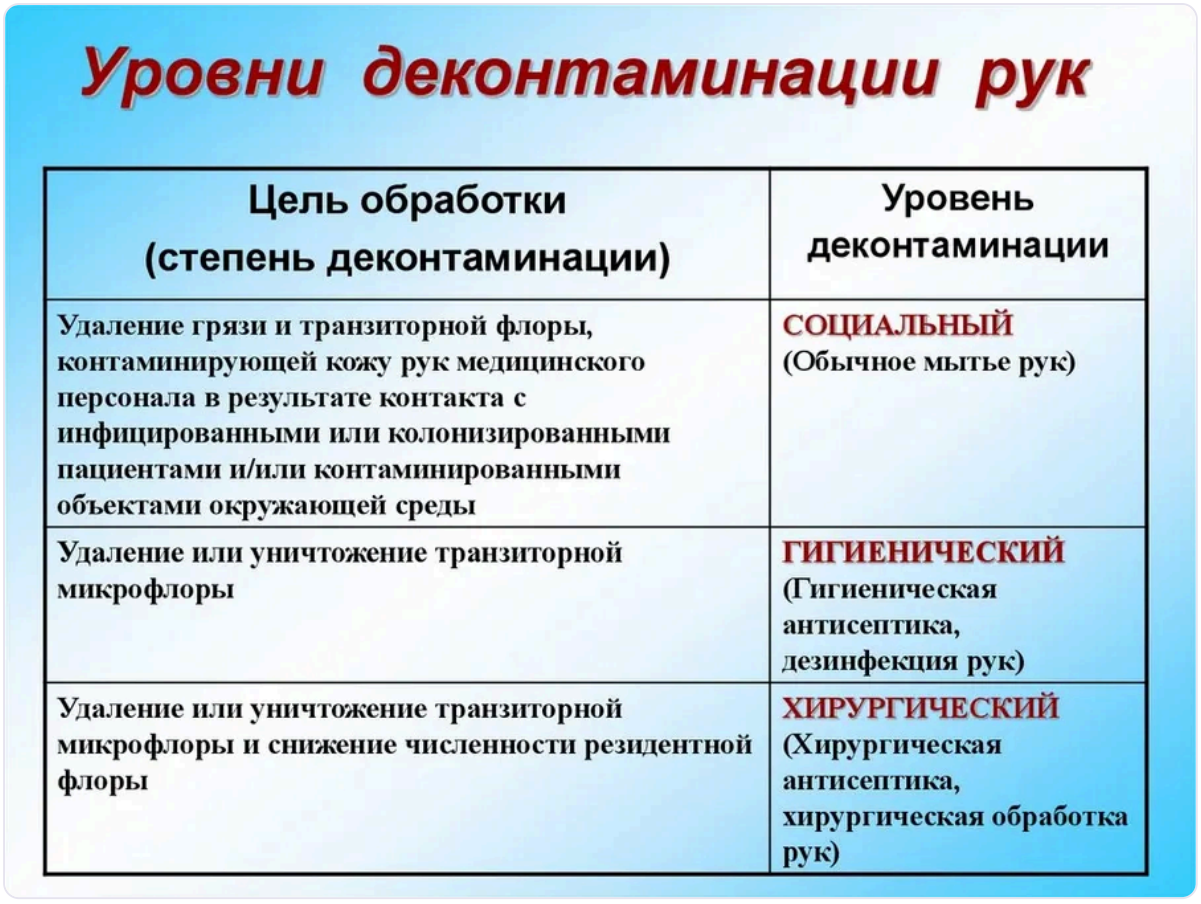
4. Уровни деконтаминации рук

СУТЬ

Обычное мытьё снимает грязь, гигиеническая обработка убивает транзиторную флору, хирургическая — ещё и снижает резидентную.



Три уровня обработки рук



Слайд: уровни деконтаминации рук



Гигиеническая обработка рук антисептиком — 6 движений

1) Гигиеническая обработка рук

Удаление загрязнений, удаление/уничтожение **транзиторной** микрофлоры. Способ — кожным антисептиком. Проводят:

- перед непосредственным контактом с пациентом, перед надеванием стерильных перчаток и после снятия перчаток;
- при постановке центрального внутрисосудистого катетера, мочевого катетера или других инвазивных устройств, если манипуляция не требует хирургического вмешательства;

- после контакта с неповреждённой кожей пациента, измерения пульса, артериального давления, перемещения пациента;
- после контакта с медоборудованием и предметами вблизи пациента.

2) Обычное (бытовое) мытьё рук

Мытьё с мылом и водой — для удаления загрязнений и снижения количества микроорганизмов.

3) Обработка рук хирургов

Удаление/уничтожение транзиторной микрофлоры и **снижение численности резидентной**. Обрабатывают руки все, кто участвует в операции. Два этапа:

1. Мытьё с мылом и водой в течение **2 минут**, высушивание стерильным полотенцем/салфеткой.
2. Обработка антисептиком кистей, запястий и предплечий; количество антисептика — по инструкции.

Стерильные перчатки надевают сразу после **полного высыхания** антисептика.

5. Если перчатки порвались или руки в крови

1. Снять перчатки.
2. Вымыть руки с мылом и водой.
3. Тщательно высушить одноразовым полотенцем.
4. Обработать кожу антисептиком **дважды**.



Стерильные перчатки: надевание и снятие

6. Аварийная ситуация: укол или порез

СУТЬ
Порез или укол грязным инструментом — промыть, обработать спиртом и йодом, заклеить, записать в журнал; при риске ВИЧ — АРТ в первые 2 часа.

Регламент — **СанПиН 3.3686-21** «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», раздел «Профилактика ВИЧ-инфекции».



Алгоритм при аварийной ситуации

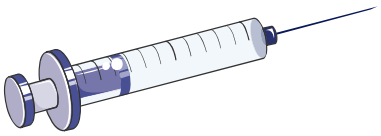
- **Порез или укол**: немедленно снять перчатки, вымыть руки с мылом под проточной водой, обработать **70% спиртом**, смазать ранку **5% раствором йода**, заклеить пластырем.
- **Кровь или другие жидкости на слизистые** глаз, носа, рта — обильно промыть водой.
- **Кровь на халат/одежду** — снять одежду и погрузить в дезраствор.
- При риске заражения ВИЧ — немедленно начать приём **антиретровирусных препаратов (АРТ)**: в первые **2 часа** после аварии, но **не позднее 72 часов**.
- Аварийную ситуацию регистрируют в **журнале учёта аварийных ситуаций** при проведении медманипуляций (приложение 14).



Аптечка «анти-ВИЧ»

Спирт этиловый 70%	1 флакон
Йод 5% спиртовой	1 флакон
Бинт стерильный	2 шт.
Лейкопластырь бактерицидный	3 шт.
Салфетки стерильные	1 упаковка

Состав аварийной аптечки



профилактика уколов и порезов

✗ Надевать колпачок на использованную иглу	✓ Сразу — в непрокалываемый контейнер
✗ Снимать иглу руками	✓ Отсекать иглу иглосъёмником
✗ Брать кровь иглой без шприца	✓ Забор крови — вакуумными системами

Как не уколоться

📌 Что запомнить

- Резидентная флора живёт и размножается постоянно; транзиторная — приобретена на работе, держится до 24 ч, смывается мытьём и антисептиком.
- Патогенная — болеют здоровые; условно-патогенная — нужен предрасполагающий фактор; оппортунисты — только при отсутствии иммунитета.
- Самые грязные зоны: подногтевое пространство, околоногтевые валики, подушечки пальцев.
- Хуже всего промываются: подногтевое пространство, межпальцевые промежутки, выемка большого пальца.
- Гигиеническая обработка — антисептиком, убирает транзиторную флору; хирургическая — мыло 2 мин + антисептик на кисти, запястья, предплечья.
- Перчатки — только после полного высыхания антисептика.
- Укол/порез: снять перчатки → мыло и вода → 70% спирт → 5% йод → пластырь → журнал. Слизистые — промыть водой.
- АРТ — в первые 2 ч, не позднее 72 ч.

🃏 Вопросы для самопроверки

Резидентная микрофлора
Постоянно живёт и размножается на коже

Транзиторная микрофлора
Приобретена при работе, держится до 24 ч, удаляется мытьём и антисептиком

Оппортунисты
Вызывают генерализованные заболевания только у людей без иммунитета

Самые загрязнённые участки рук
Подногтевое пространство, околоногтевые валики, подушечки пальцев

Самые сложно промываемые участки
Подногтевое пространство, межпальцевые промежутки, выемка большого пальца

Чем проводят гигиеническую обработку рук?
Кожным антисептиком

Два этапа хирургической обработки рук
1) мыло и вода 2 мин + стерильная салфетка; 2) антисептик на кисти, запястья, предплечья

Когда надевают стерильные перчатки?
Сразу после полного высыхания антисептика

Порезался использованным инструментом — что делать?
Снять перчатки, вымыть руки с мылом, 70% спирт, 5% йод, пластырь, запись в журнал

Когда начинать АРТ после аварии?
В первые 2 часа, не позднее 72 часов

По какому СанПиН действуют при аварии?
СанПиН 3.3686-21